



**Diagnóstico
Avançado
Por Imagem**

Liga das Senhoras Católicas de Curitiba

Portal do Paciente



Dr. Dante Luiz Escussato

Diretor Técnico Unidade Meróis
CRM-PR 6902 - RQE 3224

Dr. André Francisco Gomes

Diretor Técnico Unidade Palladium
CRM-PR 18.567 - RQE 10.778

RELATÓRIO

Nome do Paciente: Jose Valmir Rosa		
Idade: 82Y 8M	Data do Exame: 12/05/2025	Nº do Paciente: 0003238993

A/C DR(A). Luiz Augusto Bendhack

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME E DA PELVE (MULTIPARAMÉTRICA)

Foram adquiridas imagens ponderadas em T1 e T2, antes e após a injeção endovenosa de contraste paramagnético (gadolínio) e sequências funcionais para avaliação da próstata (difusão e perfusão) em equipamento 3T.

Exame realizado para investigação do aumento dos níveis de PSA (4,0 ng/mL - SIC).

Os seguintes aspectos foram observados:

Artefatos de movimento limitam a avaliação de algumas imagens.

Próstata com dimensões aumentadas à custa da zona de transição, abaulando o assoalho vesical e medindo 55 x 55 x 46 mm (volume de 72 cm³).

PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System) V.2.1

Zona Periférica: Heterogênea, com faixas de redução do sinal em T2 e realce pelo meio de contraste, sugerindo alterações de origem inflamatória.

Lesão com baixo sinal em T2, restrição à difusão da água e realce precoce pelo meio de contraste comprometendo praticamente todo o setor posterior do lobo esquerdo, estendendo-se do ápice à base, medindo 32 mm no maior diâmetro axial, suspeita para neoplasia clinicamente significativa (T2:5 , DWI:5 , DCE:+). A lesão apresenta amplo contato com a cápsula prostática, que se encontra discretamente abaulada e irregular, que pode representar componente extensão extraglandular.

Zona de Transição: hiperplasia estromal e glandular, sem a caracterização de lesões infiltrativas (T2:2 , DWI:2 , DCE:-).

Vesículas seminais com espessamento parietal e realce pelo meio de contraste (alteração crônica).

Não há evidência de linfonomegalia ou lesões ósseas destrutivas.

Bexiga parcialmente repleta, apresentando espessamento parietal difuso.

Demais achados:

Ausência de ascite.

Fígado de contornos lobulados e com acentuação das fissuras hilares.

Vesícula biliar, pâncreas e baço de morfologia habitual.

Nódulo na haste medial da adrenal esquerda, com componente de gordura microscópica e realce heterogêneo pelo meio de contraste, medindo 24 x 23 mm, cujas características favorecem adenoma. Ausência de lesões expansivas na glândula adrenal direita.

Rins com topografia e dimensões normais. Pequenos cistos peripiélicos nos seios renais.

Divertículos cólicos, sem sinais inflamatórios adjacentes.

Alterações degenerativas do esqueleto.



**Diagnóstico
Avançado
Por Imagem**

Liga das Senhoras Católicas de Curitiba

Portal do Paciente



Dr. Dante Luiz Escussato

Diretor Técnico Unidade Mercês
CRM-PR 0902 - RQE 3224

Dr. André Francisco Gomes

Diretor Técnico Unidade Palladium
CRM-PR 16.567 - RQE 10.778

RELATÓRIO

Nome do Paciente: Jose Valmir Rosa		
Idade: 82Y 8M	Data do Exame: 12/05/2025	Nº do Paciente: 0003238993

A/C DR(A). Luiz Augusto Bendhack

OPINIÃO:

O estudo por ressonância magnética do abdome e da pelve, com ênfase para avaliação da próstata (RM-mp), mostra:

Hiperplasia prostática benigna e bexiga de esforço.

Alterações na zona periférica prostática e vesículas seminais que sugerem sequelas de processo inflamatório crônico.

Lesão suspeita para neoplasia clinicamente significativa no lobo esquerdo da próstata (PI-RADS 5).

Dr Vitor Lopes Galvao Vieira
CRM - PR 33988 RQE 23281